Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Pelotas

Av. Ferreira Viana, 1134 - Bairro: Areal - CEP: 96085000 - Fone: (53) 3026-8500 - https://www.tjrs.jus.br/novo/ - Email: frpelotas2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5021185-78.2023.8.21.0022/RS

AUTOR: LUIZ FERNANDO CAMARGO VERONEZ (SUCESSÃO)
REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR: GABRIEL GUEZ VARGAS VERONEZ (SUCESSOR)
REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR: LEONARDO LEMOS VERONEZ (SUCESSOR)
REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR: LEONIDAS LEMOS VERONEZ (SUCESSOR)
RÉU: UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

I-RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por LUIZ FERNANDO CAMARGO VERONEZ em face da UNIMED PELOTAS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A DAÚDE LTDA. Alegou, em síntese, ser usuário do plano de saúde operado pela demandada, que foi diagnósticado com Ademocarcinoma de Vesícula Biliar, patologia classificada sob o CID C24 ECIV. Disse que há aproximadamente 3 anos, vem se se submetendo a esquemas de tratamento quimioterápico e cirúrgicos com Everolimus, Capacitabina, Folfirnox e radioterapia, e as tomografias apresentaram progressão hepática e elevação significativa da doença com o tratamento convencional com quimioterapia. Mencionou que lhe foi indicado o tratamento com sal Avelumade, cujo nome comercial é Bavencio, com o qual terá aumento de sobrevida, com redução de 51% de risco de progressão da doença e 23% do risco de morte. Defendeu os efeitos benéficos do uso da medicação, sendo o único capaz de amenizar o seu sofrimento, e que não é fornecida pelo SUS. Disse que a não utilização da medicação trará risco à sua vida. Narrou que solicitou a requerida o fornecimento da medicação, mas a mesma lhe foi negada. Discorreu acerca da urgência na obtenção do tratamento, bem como da legislação aplicada ao caso. Pugnou, em tutela de urgência, a condenação da ré à dispensação do fármaco. Ao final, a confirmação da liminar, bem como a condenação da demandada a indenizar dano moral no valor de 15 salários mínimos. Acostou documentos evento 1, INIC1

Indeferida a gratuidade de justiça e determinado o pagamento das custas processuais evento 3, DESPADEC1

Houve pedido de reconsideração, com a juntada de documentos evento 6, PET1e evento 8, PET1

A magistrada declarou-se suspeita e os autos foram encaminhados ao substitudo evento 9, DESPADEC1

Autorizado o parcelamento das custas e concedida a tutela de urgência pleiteada evento 11, DESPADEC1

Sobreveio aos autos a notícia do falecimento do autor evento 20, CERTOBT2

Citada, a requerida ofereceu contestação evento 23, CONT1. Alegou que autor é beneficiário do plano de saúde oferecido por ela na modalidade coletivo por adesão, firmado em 01/07/2013, o qual se encontra regulamentado pela Lei 9.656/98 e pelas resoluções provenientes da ANS, tendo sua cobertura assistencial vinculada ao Rol de Procedimentos editados pela a Agência. Sustentou que a legislação aplicada exclui, expressamente, cobertura assistencial para medicamentos de uso doméstico, fato que era do conhecimento do autor no momento da contratação. Citou jurisprudências. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.

O juízo determinou a suspensão do feito nos termos do art. 313, I e § 1º do CPC evento 23, CONT1

Os sucessores do autor falecido habilitaram-se no feito evento 34, PET1

O Ministério Público promoveu pela juntada dos documentos de identificação dos sucessores evento 39, PROMOÇÃO1, o que foi atendido evento 46, PET1

Instadas as partes a se manifestarem acerca da produção de novas provas evento 64, DESPADEC1, a demandada requereu o saneamento do processo evento 76, PET1

Em decisão saneadora evento 78, DESPADEC1 houve julgamento de extinção do processo relativamente ao pedido de tratamento domiciliar, e determinado o prosseguimento quanto ao pleito indenizatório.

A requerida se manifestou evento 93, DOC1

Determinado a parte autora a retificação do valor da causa evento 95, DESPADEC1

A parte autora retificou o valor da causaevento 104, PET1

O Ministério Publico opinou pela improcedência da ação evento 110, PROMOÇÃO1

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

II-FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas. O processo tramitou regularmente, não havendo nulidades a serem sanadas ou preliminares pendentes de análise, verifico presentes os pressupostos processuais.

Contudo, antes de adentrar no mérito, considerando as implicações decorrentes, impõe-se a correção do valor da causa.

Conforme muito bem apontado pelo Ministério Público, diante da extinção do processo relativamente à obrigação de fazer, consistente no fornecimento da medicação, tendo em vista a perda do objeto pelo falecimento do autor, o valor da causa deve corresponder ao pedido remanescente, que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais.

Assim, considerando que o pedido de indenização perfaz a quantia de R$ 45.000,00, este deve ser o valor atribuído à causa.

Deste modo, corrijo de ofício o valor da causa, para R$ 45.000,00, com fulcro no art. 292, § 3º do CPC.

Quanto ao mérito, trata-se da análise do pedido de indenização por danos morais, em razão da negativa da ré ao fornecimento da medicação Avelumabe/Bavenco, prescrita ao autor para o tratamento da doença que lhe acometia, que consistia em Ademocarcinoma de Vesícula Biliar.

A parte demandada, por sua vez, em sede de contestação, defende, em suma, a inexistência de cobertura contratual ou legal, tendo em vista o caráter domiciliar do medicamento postulado. Aduz, ainda, a inocorrência de danos morais indenizáveis.

A questão controvertida, portanto, cinge-se a apurar eventual ilicitude na conduta da ré ao negar o fornecimento dos fármacos pleiteados, a ensejar a indenização pretendida.

Pois bem.

De antemão, tenho que a relação jurídica havida entre as partes está devidamente comprovada nos autos, conforme contrato, restando flagrante a relação de consumo e, por conseguinte, a aplicação do CDC.

As relações contratuais que envolvem planos de saúde se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado pelo STJ na Súmula n.º 608:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Sobre o tema, o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98), em seu §12, prevê o caráter exemplificativo do rol da ANS:

Art. 10. (...)

§12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Assim, constata-se que o rol de procedimentos publicado pela ANS constitui apenas uma referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde. Com isso, o fato de a medicação que se pretende obter cobertura não constar no rol da ANS, por si só, não excetua sua cobertura.

Nesse sentido, aponto precedentes do Tribunal de Justiça do Estado:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO BELIMUMABE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO ANTINEOPLÁSICO. ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. ***2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI.*** *NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10.* ***3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO, O QUE FOI RATIFICADO PELA INCLUSÃO DO § 12 NO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 PELA LEI Nº 14.454/2022. (...).*** *7. DE CONSEQUÊNCIA, COM FULCRO NO §11 DO ARTIGO 85 DO CPC, RESTAM MAJORADOS OS HONORÁRIOS*

DEVIDOS PELA PARTE AUTORA AOS PROCURADORES DA PARTE RÉ APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50034053920218210041, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-06-2023). Grifei.

Embora o plano de saúde possa estabelecer as doenças que terão coberturas, não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o seu paciente. No caso, o plano de saúde tem cobertura para a doença apresentada pela parte autora, motivo pelo qual foi deferida tutela provisória de urgência em 14/07/2023 evento 11, DESPADEC1.

Ocorre que, considerando o caráter domiciliar da aplicação do fármaco em comento, cabe assinalar que a matéria em exame passou por modificação de entendimento pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, tendo a Des. Rel. LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA consignado, em seu voto, no julgamento da apelação cível nº 5003405-39.2021.8.21.0041/RS, desprovida por unanimidade, o seguinte trecho:

"Dito isso e considerando a recente jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita, que ***considera legítima a recusa de cobertura pelas operadoras de plano de saúde de medicamentos de uso domiciliar*** *que não sejam antineoplásicos ou de uso em regime de home care,* ***destaco que revi o meu posicionamento anteriormente exarado acerca da matéria."***

Ementa do acórdão mencionado:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO BELIMUMABE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO ANTINEOPLÁSICO. ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO, O QUE FOI RATIFICADO PELA INCLUSÃO DO § 12 NO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 PELA LEI Nº 14.454/2022. 4. NÃO OBSTANTE O CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS, SALIENTA-SE QUE O ART. 10 DA LEI 9.656/98 APRESENTA HIPÓTESES EXPRESSAS EM QUE SE POSSIBILITA A EXCLUSÃO DE COBERTURA PELAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE, DENTRE AS QUAIS ESTÁ INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, À EXCEÇÃO DOS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E MEDICAÇÕES EM REGIME DE HOME CARE. 5. NESSE CONTEXTO E CONSIDERANDO A RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA MATÉRIA, AS OPERADORAS DE SAÚDE, SALVO CONTRATAÇÃO QUE AMPLIE O ÂMBITO DE COBERTURA, NÃO DETÊM OBRIGAÇÃO DE COBRIR MEDICAMENTOS QUANDO EM USO DOMICILIAR, EXCETUADOS OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E MEDICAÇÕES EM REGIME DE HOME CARE - HIPÓTESES DISTINTAS DA QUE SE OBSERVA NO PRESENTE FEITO. 6. DITO ISSO, NÃO HÁ FALAR EM DEVER DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DO MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR PLEITEADO, AFIGURANDO-SE LEGÍTIMA A RECUSA DE FORNECIMENTO. 7. DE CONSEQUÊNCIA, COM FULCRO NO §11 DO ARTIGO 85 DO CPC, RESTAM MAJORADOS OS HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA AOS PROCURADORES DA PARTE RÉ APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50034053920218210041, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-06-2023).

Nesse ponto, não obstante o caráter exemplificativo do rol da ANS, o art. 10 da Lei 9.656/98 apresenta hipóteses expressas em que se possibilita a exclusão de cobertura pelas operadoras de plano de saúde, dentre as quais está incluído o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, à exceção dos antineoplásicos orais e medicações em regime de *home care.*

É a previsão legal:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II - quando incluir internação hospitalar:

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Por conseguinte, formou-se entendimento de que é considerada legítima a recusa de cobertura pelas operadoras de plano de saúde de medicamentos de uso domiciliar que não sejam antineoplásicos ou de uso em regime de *home care.*

Portanto, pela compreensão atual, as operadoras de saúde, salvo contratação que amplie o âmbito de cobertura, não detêm obrigação de cobrir medicamentos quando em uso domiciliar, à exceção dos antineoplásicos orais e medicações em regime de *home care* - hipóteses distintas da que se observa no presente feito.

A respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DOMICILIAR. ENOXAPARINA. AUSENCIA DO ROL DA ANS. SENTENÇA REFORMADA. - No que tange aos medicamentos de uso domiciliar, o STJ tem entendimento de que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim". - Caso em que não é devido o custeio do medicamento almejado, pois, além de ser de uso domiciliar, não está presente no rol de cobertura obrigatória da ANS, nem objeto de contratação específica junto à ré. - Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Apelo da parte autora prejudicado. Ônus sucumbenciais redimensionados. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50183218620228210027, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 27-06-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DO FÁRMACO ENOXAPARINA. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. A LEI 9.656/98 PREVÊ A POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DESTA COBERTURA, EXCETUANDO APENAS OS MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES, DO QUE NÃO SE CUIDA O CASO DOS AUTOS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO CPC. REVOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51380272820248217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 27-06-2024)

Destarte, embora a concessão da tutela provisória de urgência, o exame do mérito requerer um estudo aprofundado e em atenção ao conjunto normativo incidente, assim como ao posicionamento jurisprudencial, o qual passo a observar para o exame em cognição exauriente.

Veja-se que, a parte autora postulou a cobertura pela ré do medicamento AVELUMAB 20MG evento 1, LAUDO9 evento 1, RECEIT10 o qual consiste em fármaco de uso domiciliar - que não se enquadra nas exceções legalmente previstas, já referidas acima.

Outrossim, o contrato expressamente dispõe sobre a exclusão de fornecimento de medicamento fora do regime de internação hospitalar e qualquer serviço ambulatorial exclusivo para aplicação de medicamento que pode ser realizado no domicílio evento 23, CONTR2

TEMA IV . EXCLUSÕES DE COBERTURA

Cláusula 50: Estão expressamente excluídos deste contrato, não gerando direito a qualquer tipo de cobertura, sem prejuízo das limitações previstas nas cláusulas subseqüentes, os seguintes procedimentos:

VI. fornecimento de todo e qualquer tipo de medicamento, material, equipamento e enfermagem para tratamento fora do regime de internação hospitalar;

Com efeito, ante a ausência de previsão contratual para a cobertura de medicações de uso domiciliar (pelo contrário, tem-se a expressa exclusão do fornecimento pretendido), que encontra respaldo legal de exclusão de cobertura (art. 10, VI, da Lei 9.656/98), não há falar em dever de fornecimento pela operadora do plano de saúde, afigurando-se legítima a recusa pela ré.

Destarte, diante da análise realizada em cognição exauriente e em atenção ao recente posicionamento jurisprudencial sobre o tema, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade na negativa de cobertura da medicação pela ré, pois esta se encontra amparada pela legislação e pela jurisprudência aplicáveis ao caso.

Assim, deve ser afastada a pretensão indenizatória, seja por inexistir ilicitude na conduta da ré, ou falha na prestação do serviço, seja pela ausência da comprovação dos danos.

Com efeito, o arbitramento de indenização por dano extrapatrimonial pressupõe a demonstração de abalo relevante à esfera anímica do ofendido, que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual ou da frustração de uma expectativa legítima. No presente caso, os elementos constantes dos autos não evidenciam situação capaz de justificar a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de reparação moral, seja sob o ponto de vista fático, seja à luz da jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Saliento, ainda, que não se está diante de hipótese de dano moral presumido ou *in re ipsa*, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. TRATAMENO DE TEA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em regra, recusa indevida de cobertura de tratamento médico não gera danos morais in re ipsa, sendo necessário para tanto a comprovação do agravamento da situação de saúde ou o abalo psicológico, o que se verifica, contudo, na recusa indevida/injustificada pela operadora de saúde em autorizar a cobertura financeira para tratamento médico de urgência ou emergência, o que não ocorreu na hipótese em exame.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.083.260/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.);

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA NÃO APLICÁVEL. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente" (AgInt no AREsp n. 1.185.578/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).
2. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.052.833/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.);

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.988.367/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

Portanto, indispensável, para que exsurja o dever de indenizar, a existência de provas concretas da repercussão extrapatrimonial oriunda do ato ilícito atribuído à parte adversa.

Dito isso, no caso em concreto, verifico que não sobreveio da prova produzida no feito a demonstração de que o evento ocorrido (negativa de fornecimento de medicamento) tenha gerado a parte autora dano extrapatrimonial no que se refere aos seus direitos de personalidade, tampouco acarretado humilhação à sua esfera íntima, na medida em que embasada a negativa em interpretação contratual por parte da operadora.

Outrossim, nota-se que a negativa da operadora do plano de saúde foi fundamentada nas disposições contratuais, visto que o segurado tinha convicção que o pleito tratava-se de medicamento para uso domiciliar.

Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgo **IMPROCEDENTE** os pedidos formulados pela **SUCESSÃO DE** LUIZ FERNANDO CAMARGO VERONEZ contra **UNIMED PELOTAS/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**

Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao procurador da parte contrária, os quais vão fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a contar da data da sentença e com juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 16 do CPC.

Retifique-se o polo ativo da ação, onde deverá constar Sucessão de LUIZ FERNANDO CAMARGO VERONEZ, bem como o valor da causa, conforme constou na sentença.

Publicação e intimação automáticas. Sem necessidade de registro.

Em face da sistemática do Código de Processo Civil e, diante da inexistência de juízo de admissibilidade, (art. 1010, § 3º do CPC), em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se na intimação da parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao Tribunal de Justiça.

Trânsita, baixe-se, satisfeitas eventuais custas pendentes. Não havendo o pagamento das custas, proceda-se de acordo com os arts. 524 e 525 da CNJ.

Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GRANATO RODRIGUES, Juiz de Direito**, em 28/08/2025, às 16:45:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10088442820v19** e o código CRC **dbca81a0**.